経胸壁心エコー図における非典型的短絡血流を呈したロングトンネル卵円孔開存の 1 例

◎中村 真大[1)]、関根 綾子[1)]、伊藤 亜衣梨[1)]、加藤 遼[1)]、加藤 憂朔[1)]、中森 恵[1)]、中山 純里[1)]、菊地 良介[1)]
岐阜大学医学部附属病院[1)]

【背景】卵円孔開存（PFO）は成人の約 20%に認められる心房中隔の形態異常であり，奇異性脳塞栓の原因として重要である．今回，経胸壁心エコー図（TTE）で評価に苦慮したロングトンネル PFO の一例を経験したので報告する．
【症例】70 歳代女性．20XX 年 3 枝病変を伴う狭心症および重症大動脈弁狭窄症に対し，大動脈弁置換術，冠動脈バイパス術および PFO 閉鎖術が施行され，経過観察目的で TTE を施行した．
【心エコー図所見】検査時，上室性期外収縮二段脈であった．左室駆出率は 61%で正常範囲内であり，僧帽弁両尖の弁輪部に石灰化を認め，軽度～中等度の僧帽弁狭窄および左房拡大を認めた．三尖弁逆流は軽度で，最大三尖弁逆流速度は 2.9m/s であった．カラードプラ法にて左房から右房への短絡血流を認めた．また，大動脈弁レベル短軸断面にて，収縮期に大動脈近傍から心房中隔に沿って心房天蓋へ向かう異常血流を認めたが，TTE のみでは起源の特定に至らなかった．後日施行した経食道心エコー図（TEE）にて，心房中隔の重なりが 14mm と長いトンネル状構造を認め，ロングトンネルを伴う PFO および可動性心房中隔と診断された．
【考察】本症例では，外科的 PFO 閉鎖術後であったが，非リウマチ性（あるいは石灰化性）僧帽弁狭窄の進行による左房拡大，左房圧上昇を契機に左→右短絡血流が顕在化した可能性が考えられた．一般に心房中隔の重なるトンネル長が 10mm 以上の場合をロングトンネルとよぶ．ロングトンネル PFO は解剖学的に複雑な形態を有することが報告されている．外科的閉鎖後においても、弁膜症などによる血行動態変化が PFO を再顕在化させうること，そして，ロングトンネル PFO は，短絡血流が非典型的な血流として観察されることを念頭に置き，総合的な評価を行うことが重要であると考えられた．

（連絡先 058-230-7261）